Ostéome ostéoïde intra-articulaire de la hanche (cotyle) traité par radiofréquence guidée par scanner : supériorité sur l'arthroscopie

Titre original : Intraarticular acetabular osteoid osteoma treated with CT-guided radiofrequency ablation after unsuccessful arthroscopy: a case report and literature review

Auteurs : Nitta K, Saito M et al. | **Revue :** *Skeletal radiology* (**IF : 1.9**) | **Date :** Oct. 2026 | **PMID :** 42931896 | **Modalité :** Scanner TDM

1. Pertinence Clinique & Lien avec l'Agenda Interventionnel (Cochin)

En lien direct avec la prise en charge à Cochin (IRM dynamique + RF sous AG) des ostéomes ostéoïdes intra-articulaires de hanche chez l'adolescent et l'adulte jeune.

2. Synthèse Clinique en Français

Résumé exécutif : Publication d'octobre 2026 (*Skeletal Radiology*) illustrant le traitement curatif par radiofréquence sous scanner d'un ostéome ostéoïde intra-articulaire de la fosse acétabulaire après échec d'une résection arthroscopique, avec disparition complète de la synovite réactionnelle et des douleurs.

Analyse détaillée : Les ostéomes ostéoïdes intra-articulaires de la hanche (cotyle, col fémoral) provoquent une synovite inflammatoire sévère, un épanchement articulaire et un remodelage arthrosique précoce mimant une coxite. L'abord arthroscopique est souvent mis en échec dans les localisations médiales profondes de la fosse acétabulaire. Le guidage scanner permet une trajectoire trans-osseuse extra-capsulaire millimétrique jusqu'au nidus avec thermocoagulation RF complète et préservation du cartilage articulaire.

3. Protocole Technique & Paramètres Opératoires

Repérage TDM en coupes fines • Abord trans-iliaque ou rétro-acétabulaire extra-articulaire évitant le cartilage hyalin • Sonde RF monopolaire 90 °C pendant 6 minutes • Contrôle IRM montrant la régression de la synovite et de l'œdème médullaire.

4. Points Clés à Retenir pour la Pratique

- Les ostéomes ostéoïdes intra-articulaires de hanche s'accompagnent d'une synovite réactionnelle floride et d'une absence d'ostéosclérose périphérique.
- La RF sous scanner offre un accès direct aux nidus profonds du cotyle inaccessibles en arthroscopie.
- Privilégier une voie trans-osseuse extra-articulaire pour protéger le cartilage acétabulaire et le nerf sciatique.
- Résolution rapide de l'épanchement articulaire et des douleurs nocturnes dès la première semaine.

5. Original PubMed Abstract (Texte Intégral de l'Abstract)

Acetabular osteoid osteoma is uncommon, and treatment can be difficult when the lesion is intraarticular or associated with osteoarthritis. We report a 17-year-old male with an intraarticular acetabular osteoid osteoma. The lesion was located in the medial portion of the acetabular fossa and was associated with synovitis, joint effusion, joint space narrowing, and osteophyte formation. Arthroscopy was initially selected for lesion resection and joint assessment. However, the medial location limited instrument access, preventing complete resection. The residual lesion was subsequently treated with CT-guided radiofrequency ablation (RFA) using a posterior osseous trajectory and intraarticular cooling with chilled 5% dextrose solution. At 4 weeks, hip pain had completely resolved, and MRI showed resolution of perilesional bone marrow edema. Pain relief persisted through 12 months without analgesic use. A literature review summarizes previous treatment approaches for

acetabular osteoid osteoma. This case illustrates that treatment planning should account for lesion location, joint condition, and technical feasibility. CT-guided RFA may be useful when a safe percutaneous trajectory to the lesion can be planned.